



• GUIA GRATUITO

Guia da **Triagem** **neonatal**

Pezinho, orelhinha,
coraçãozinho e
olhinho

Para a
enfermagem:
janela, técnica e
registro.



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC

• PARTE 1 • TESTE DO PEZINHO

01

Pezinho: janela e etapas

O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) existe desde 6/6/2001. O teste do pezinho é direito de todo recém-nascido vivo e dever do Estado. Quem coleta, na maioria das vezes, é a enfermagem.

1

Nunca antes de 48h

Antes de 48 horas de vida o resultado pode não ser confiável. O MS recomenda a 1ª amostra entre 48h e o 5º dia de vida.

2

Atrasou? Colete

Fora da janela, colete em até 30 dias. Depois do 28º dia, a coleta é exceção e a criança deve ser avaliada pelo serviço médico.

3

Por que a pressa

O hipotireoidismo congênito precisa ser tratado até os 14 dias de vida para evitar atraso no desenvolvimento.

O que a Lei 14.154/2021 mandou rastrear, em 5 etapas

Etapa	Doenças (art. 10 do ECA)	Situação nacional
1	Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita	No SUS. A toxoplasmose foi a única doença incluída no PNTN depois da lei (repasso em 2022)
2	Galactosemias, aminoacidopatias, distúrbios do ciclo da ureia e da betaoxidação dos ácidos graxos	Ainda não implantadas em todo o país. O plano do MS prevê concluir as 5 etapas até 2030
3	Doenças lisossômicas	
4	Imunodeficiências primárias	
5	Atrofia muscular espinhal (AME)	

Depende do seu estado. Segundo o Ministério da Saúde (set/2025), só o DF e Minas Gerais fazem as 5 etapas. O Rio de Janeiro implantou a etapa 2 e o Mato Grosso do Sul aprovou em jun/2025 as etapas 2, 4 e 5. Pergunte ao Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN) do seu estado o que ele faz hoje.

67% no prazo

Em 2024, só 67,11% dos bebês do Brasil coletaram até o 5º dia. Goiás ficou em 54,51% e o DF em 88,07%. Cobertura geral: 87,24%.

Orientar é obrigação

A lei manda informar a gestante, no pré-natal e no puerpério imediato, sobre o teste e as diferenças entre o que o SUS e a rede privada oferecem.

A coleta que o laboratório não devolve

Amostra ruim vira reconvocação, e reconvocação atrasa diagnóstico. Os passos abaixo resumem o Manual Técnico de Triagem Neonatal Biológica do Ministério da Saúde.

- 1 Posição.** Calcanhar abaixo do nível do coração, bebê no colo do acompanhante em pé, com a cabeça no ombro dele. Evite ar-condicionado: pé frio sangra pouco.
- 2 Antissepsia.** Álcool 70% e espere secar por completo. Nunca álcool iodado ou antisséptico colorido, que interferem nas análises.
- 3 Punção.** Lanceta estéril, descartável e autorretrátil, com 1,8 a 2,0 mm de profundidade, na lateral da região plantar do calcanhar.
- 4 Gotas.** Despreze a 1ª gota. Encoste o verso do papel na nova gota e faça movimentos circulares até preencher o círculo. Nunca volte a um círculo já usado nem colete dos dois lados.
- 5 Confira contra a luz.** O sangue precisa atravessar o papel de forma homogênea. Na dúvida, repita em cartão novo antes de liberar o bebê.
- 6 Seque na horizontal.** Temperatura ambiente, cerca de 3 horas, sem sol, estufa, ventilação forçada ou empilhamento. Não deixe a amostra mais de 2 dias na unidade.

RN prematuro, de baixo peso ou internado na UTI neonatal

Amostra	Quando	Por quê
1ª (punção venosa)	Na admissão na UTI	Antes de nutrição parenteral, transfusão, corticoide, aminos ou antibiótico
2ª (punção venosa)	Entre 48h e 72h de vida	Independente da condição clínica
3ª	Na alta ou aos 28 dias, o que vier antes	Foco em IG < 34 semanas ou peso < 2.000 g (risco de falso-negativo de tireoide e HAC)

No prematuro, o manual recomenda evitar punções de calcanhar e não usar a linha venosa de infusão ou de nutrição parenteral.

CÁLCULO RESOLVIDO

Qual a janela de cada teste deste bebê?

RN de 39 semanas, alojamento conjunto, nasceu em **02/10 às 22h**. Alta prevista para 04/10 às 10h (36h de vida).

Coraçãozinho (24h a 48h): de **03/10 22h a 04/10 22h**. Faça antes da alta das 10h.

Pezinho (a partir de 48h): só a partir de **04/10 às 22h**. Com alta às 10h, não dá para colher na maternidade.

Conduta: orientar e registrar a ida à UBS. Considerando o dia do nascimento como 1º dia de vida, o 5º dia é **06/10**.

Orelhinha e olhinho: antes da alta, ainda na maternidade.

Cálculo da ITH. Confirme com o SRTN do seu estado a forma de contar os dias de vida e registre no prontuário a data e a hora do nascimento e da coleta.

Oximetria e audição antes da alta

O teste do coraçãozinho é universal no SUS desde 2014. Ele procura a hipoxemia das cardiopatias congênitas críticas numa fase em que o bebê ainda parece bem.

Teste do coraçãozinho (SBP, 2022)	Como fazer
Quem	Todo RN com IG de 35 semanas ou mais, assintomático, no alojamento conjunto
Quando	Entre 24h e 48h de vida, antes da alta
Onde	Mão direita (pré-ductal) e um dos pés (pós-ductal), com sensor neonatal, extremidades aquecidas e onda de pulso estável
Negativo	$SpO_2 \geq 95\%$ nos dois locais e diferença $\leq 3\%$: rotina da maternidade
Duvidoso	SpO_2 entre 90% e 94% ou diferença $\geq 4\%$: repetir após 1 hora, por até 2 vezes
Positivo	$SpO_2 \leq 89\%$ em qualquer local, ou duvidoso pela 3ª vez: avaliação médica e ecocardiograma. Não dar alta antes do esclarecimento

CÁLCULO RESOLVIDO

Interprete esta oximetria (caso fictício)

RN de 38 semanas, 30h de vida. 1ª medida: mão direita 97%, pé 93%. Pé entre 90 e 94% e diferença de 4%: **duvidoso**. Repetir em 1h.

2ª medida: mão 97%, pé 94%. A diferença caiu para 3%, mas o pé segue abaixo de 95%: **duvidoso de novo**.

3ª medida: mão 98%, pé 96%. Os dois $\geq 95\%$ e diferença de 2%: **negativo**. Registre as 3 medidas com hora.

A armadilha: diferença $\leq 3\%$ não basta, os dois valores precisam estar em 95% ou mais. O protocolo da Conitec de 2014 usava corte de diferença $\geq 3\%$ e uma só repetição: siga o protocolo da sua instituição. Teste negativo não exclui cardiopatia.

Teste da orelhinha (Triagem Auditiva Neonatal)

Sem indicador de risco

Emissões otoacústicas (EOA), obrigatórias por lei desde 2010. Falhou duas vezes? Faça o PEATE automático. Reteste em até 30 dias.

Com indicador de risco (IRDA)

PEATE automático direto. UTI por mais de 5 dias, ventilação, ototóxicos, hiperbilirrubinemia, peso < 1.500 g e infecções congênitas são indicadores.

Prazos do MS: triagem até o 1º mês (ou até o 3º mês de idade corrigida no prematuro), diagnóstico até o 3º mês e intervenção antes do 6º mês.

Olhinho e o papel da enfermagem

O teste do reflexo vermelho é feito com oftalmoscópio direto, em sala na penumbra, sem colírio. Pela SBP, o pediatra faz antes da alta da maternidade.



Presente

Reflexo vermelho simétrico nos dois olhos. Repetir nas consultas de puericultura.



Duvidoso

Assimetria evidente entre os olhos. Encaminhar ao oftalmologista.



Ausente

Em um ou nos dois olhos (ex.: leucocoria). Encaminhar ao oftalmologista.

Catarata e glaucoma congênitos e retinoblastoma estão entre as causas de reflexo alterado. Em 2026, o MS pôs em consulta pública um novo guia de triagem ocular que propõe o teste nas primeiras 48h e repetições aos 2, 6, 9, 12, 18 e 24 meses.

- 1 Orientação.** Explique cada teste à família ainda no pré-natal e no alojamento conjunto, e por que o pezinho não pode ser antes de 48h. Recusa deve ser documentada com assinatura do responsável.
- 2 Registro.** No cartão do pezinho: data e hora do nascimento e da coleta, peso, prematuridade e transfusão (com data). Tudo na Caderneta da Criança.
- 3 Busca ativa.** Bebê que saiu sem coleta, falhou na orelhinha ou teve reconvocação precisa de retorno agendado e conferido.

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Registro de triagem neonatal

Teste	Janela	Data e hora	Resultado e conduta
RN de · IG · peso	Nasceu em		
Coraçãozinho · mão D / pé	24h a 48h		
Coraçãozinho · repetições	+1h, +2h		
Orelhinha · EOA ou PEATE-A	Antes da alta		
Olhinho · OD / OE	Antes da alta		
Pezinho · 1ª amostra	48h ao 5º dia		
Retorno, reteste ou busca ativa	Agendar		

• FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Todas as fontes foram consultadas em 04/10/2026. A conta de janelas da Parte 2 e o caso de oximetria da Parte 3 são exemplos fictícios montados pela ITH a partir dessas fontes.

- 01** Lei nº 14.154/2021 (rol mínimo do teste do pezinho, art. 10 do ECA)
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14154.htm
- 02** BVS/MS: 6/6, Dia Nacional do Teste do Pezinho 2026 (janela de coleta e doenças do SUS)
bvsmms.saude.gov.br/6-6-dia-nacional-do-teste-do-pezinho-2026
- 03** MS: Triagem Neonatal Biológica, Manual Técnico (2016)
bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/triagem_neonatal_biologica_manual_tecnico.pdf
- 04** MS: resposta ao Requerimento de Informação nº 3.918/2025 (Notas Técnicas, set/2025: status das etapas, cobertura e coleta até o 5º dia por UF)
camara.leg.br (RIC 3918/2025)
- 05** Conitec: Relatório nº 115 e Portaria SCTIE/MS nº 20/2014 (teste do coraçãozinho no SUS)
docs.bvssalud.org/biblioref/2017/11/875369/testecoracaozinho-final.pdf
- 06** SBP: Sistematização do atendimento ao RN com suspeita ou diagnóstico de cardiopatia congênita (nº 4, 11/08/2022)
sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23544c-MO_Sistemat_atend_RN_cSuspeita_CardCongenita.pdf
- 07** Lei nº 12.303/2010 (obrigatoriedade das emissões otoacústicas)
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12303.htm
- 08** MS: Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal
bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_triagem_auditiva_neonatal.pdf
- 09** SBP: Teste do reflexo vermelho, Documento Científico nº 1 (set/2018)
sbp.com.br/fileadmin/user_upload/_20958d-DC_No1_set_2018-_Teste_do_reflexo_vermelho.pdf
- 10** MS: consulta pública do Guia para Triagem Ocular Neonatal (13 a 28/02/2026, minuta)
gov.br/saude (consultas públicas 2026)
- 11** Coren-PE: Parecer Técnico nº 11/2023 (oximetria de pulso pelo enfermeiro)
coren-pe.gov.br

Ressalvas. O rol do teste do pezinho muda de estado para estado e pode ser ampliado a qualquer momento: confirme com o SRTN. O guia de triagem ocular de 2026 ainda era minuta em consulta pública. O que cada categoria da enfermagem pode executar segue a Lei 7.498/1986 e os pareceres do Coren do seu estado. Interpretação diagnóstica e conduta são médicas.



• PARA IR ALÉM

Quer cuidar do recém-nascido mais grave?

A triagem é a porta de entrada. Na UTI neonatal e pediátrica, a enfermagem precisa decidir rápido sobre PICC, ventilação mecânica e urgência neopediátrica.

Pós-graduação em UTI Neonatal e Pediátrica

- ✓ Simulação realística em laboratório
- ✓ PICC, ventilação mecânica e urgência neopediátrica
- ✓ 440h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- ✓ Diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5)

[Quero conhecer a pós](#)mkt.faculdadeith.com.br/lp/uti-neonatal-pediatria-captura/

Resumo em 30 segundos

48 h

idade mínima para colher o teste do pezinho

24 a 48 h

janela do teste do coraçãozinho

≥ 95%

SpO2 na mão e no pé para o teste ser negativo

67%

dos bebês do Brasil colheram o pezinho até o 5º dia em 2024